Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 26ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº **0062741-73.2022.8.17.2001**

AUTOR: J. G. V. D. D. S.
REPRESENTANTE: UELITAMARA VIEIRA DUARTE

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

-

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. PREVISÃO NO ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE CUSTEIO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Vistos etc.

Júlio Gabriel Vieira Duarte de Sá, menor representado por sua genitora e através de advogado constituído, propôs a presente ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais em face da **Bradesco Saúde S/A**, igualmente identificada.

O autor aduz ser usuário de plano de saúde contratado junto a seguradora de saúde ré, sendo diagnosticado como portador de grave deficiência no crescimento, necessitando de tratamento por meio de hormônio de crescimento Somatropina na dose de 0,1u-kg-dia.

Explanou ter recebido negativa administrativa, requerendo a aplicação das normas de proteção ao consumo para imediata autorização por meio de liminar. No mérito, requereu a confirmação da liminar e a condenação do réu em danos morais. Juntou procuração, documentos e recolheu custas.

O juízo determinou a citação do réu e se reservou para apreciar o pedido de tutela provisória após o contraditório (ID nº 107826691).

Em defesa, o réu apresentou contestação suscitando preliminar de ausência de negativa. No mérito, aduziu inexistência de cobertura contratual e legal para o tratamento com a mediação requerida. Fundamentou na taxatividade de rol da ANS e argumentou pela ausência de danos morais indenizáveis.

Deferida a liminar, o juízo determinou a intimação da autora para réplica e das partes para especificação de provas (ID nº 109577280).

O Autor informou descumprimento da liminar e apresentou orçamentos (ID nº 110380886 e 110900493), ao passo em que o réu informou a apresentação de recurso de agravo (ID nº 110935261).

Após informação de novo descumprimento (ID nº 111299663), o juízo manteve a decisão agravada e determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD (ID nº 111847819), o autor requereu expedição de alvará (ID nº 112087806) e o réu aduziu dificuldades na entrega da medicação (ID nº 112467720).

Determinado e expedido alvará eletrônico (ID nº 112392782 e 112707993), a Diretoria Cível certificou o decurso do prazo sem apresentação de réplica e especificação de provas (ID nº 113055854).

O juízo julgou improcedente a ação (ID nº 113494912) e o autor apresentou embargos de declaração (ID nº 114232544).

Após manifestação do embargado (ID nº 117131367) e do Ministério Público (ID nº 123732365), o juízo acolheu os embargos, anulou a questão e determinou a manifestação do membro do parquet (ID nº 124439513).

Apresentado parecer do representante do Ministério Público (ID nº 127179470) e os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a decidir.

Trata-se de ação ordinária na qual a representante da autora pede a condenação do réu no fornecimento de especifico homônimo para crescimento da menor, além de condenação em danos morais.

Por sua vez, o réu alega exclusão contratual por se tratar de medicamento de uso domiciliar e por inexistir previsão em rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Após uma análise detalhada do caso, revejo meu posicionamento anterior.

A Lei dos Planos de Saúde possui previsão de não cobertura obrigatória para fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, conforme se percebe do art. 10,

> **Art. 10**. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, **exceto**:
> (omissis)
> **VI** - **fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12**;
> (omissis) (*destaquei*)

As ressalvas apontadas na lei dizem respeito aos medicamentos antineoplásicos orais (e correlacionados).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, outrora oscilante, pacificou-se, no final de 2022, no sentido de entender válida a limitação legal de fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, acrescentando mais algumas exceções, conforme se percebe do acórdão proferido pela sua Segunda Seção:

> AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ.
> 1. **É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.**
> Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).
> 2. A medicação intravenosa ou injetável que neces site de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).
> 3. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.
> 4. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

5. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

No voto condutor do acórdão, o STJ reconhece que o colegiado proferiu decisões no sentido contrário, mas que essa jurisprudência já se encontrava superada e cita acórdãos recentes.

Ressalto o seguinte trecho do voto:

"De fato, os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde, porquanto a obrigatoriedade de custeio dos fármacos, na Saúde Suplementar, dá-se durante a assistência em unidade de saúde, na internação hospitalar (abrangido o home care), na quimioterapia oncológica ambulatorial, na hipótese de antineoplásicos orais para uso domiciliar (e correlacionados), e naqueles relativos a procedimentos listados no rol da ANS.
De acordo com a Resolução Normativa (RN) nº 338/2013 da ANS (hoje, RNANS nº 465/2021), a qual atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, medicamento de uso domiciliar é aquele prescrito pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde.
Ressalta-se também que a medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida) (REsp nº 1.927.566/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/8/2021).
Logo, no caso, como o tratamento medicamentoso é realizado em ambiente externo ao de unidade de saúde (uso domiciliar), não há como afastar a limitação do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, que, por sua vez, foi também prevista contratualmente".

Constatada a legalidade da cláusula contratual que afasta a cobertura para o fornecimento de medicamento de uso domiciliar, resta verificar se o medicamento requerido pelo autor se encontra em alguma ressalva prevista na lei ou na decisão da Segunda Seção do STJ, acima transcrita.

O medicamento objeto da presente demanda é o hormônio do crescimento (Somatropina). Não se trata de medicamento antineoplásico ou correlacionado e também não é medicação para uso em internamento domiciliar (*home care*), restando analisar apenas se está incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Consultando o anexo I do "rol de procedimentos e eventos em saúde (RN 465/2021) da ANS, percebo que existe a expressa previsão do hormônio do crescimento (HGH) para os planos referência (pág. 87). Observo, ainda, que não há qualquer diretriz de utilização (DUT) para o referido medicamento, razão por que a negativa da seguradora é indevida.

Ressalto que a posição do Tribunal de Justiça de Pernambuco é no mesmo sentido, ou seja, reconhece a previsão do hormônio do crescimento no rol de procedimentos da ANS, o que atrai a cobertura obrigatória. Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Negativa de cobertura indevida. Segurada Baixa Estatura Idiopática. Hormônio do crescimento. Necessidade de cobertura. Resolução normativa n. 465/21 da ANS. Recurso provido. Decisão unânime. 1. **O hormônio do crescimento foi indicado pelo médico da segurada e a sua cobertura está prevista na Resolução Normativa n. 465/21 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que dispõe sobre o rol mínimo de procedimento obrigatórios. Deve haver, portanto, a cobertura.** 2. Dado provimento ao recurso da segurada, para determinar à Seguradora o fornecimento do medicamento, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00,

limitada a R$ 100.000,00. ACÓRDÃO: Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos da Agravo de instrumento n. 0003860-92.2021.8.17.9000, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça que compõem a 3ª Câmara Cível, unanimemente, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório, do voto e da ementa e notas taquigráficas que integram o presente julgado.
(TJ-PE - AI: 00038609220218179000, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 22/12/2021, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto)

PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE MEDICAMENTO. DIAGNÓSTICO. RETARDO PROGRESSIVO DO CRESCIMENTO. ESTÁGIO PUBERAL M1P1 PARA MENINAS DE 9 ANOS. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. COBERTURA OBRIGATÓRIA NO ROL DA ANS. SOMATROPINA. REGISTRO ANVISA.TRATAMENTO. INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVAABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. E MENTUTENÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. **O Rol de Procedimentos da ANS prevê expressamente a cobertura de hormônio do crescimento ((Resolução Normativa 428, no anexo I, página 62).** 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, uma vez coberta pelo plano a moléstia que acomete o paciente, não é possível à operadora limitar o tratamento a ser utilizado, especialmente quando devidamente prescrito pelo médico responsável. Comprovada a eficácia do medicamento para aplicação recomendada pela ANVISA, deve o Plano autorizar o tratamento. 3.Quantum indenizatório mantido no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não comporta minoração. 4.Dado o não provimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Recuso da Unimed Recife não provido. Decisão unânime.
(TJ-PE - AC: 00035157420218172001, Relator: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 14/07/2022, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. MENOR COM DÉFICIT NA PRODUÇÃO DO HORMÔNIO. NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO HORMONAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO - O tratamento prescrito para Davi é de natureza endocrinológica e se destina evidentemente à manutenção de sua vida e, portanto, enquadra-se na cobertura contratualmente prevista. Ora, não procede a alegação da seguradora de que a negativa se justificaria porque o tratamento solicitado não estaria previsto como cobertura obrigatória no rol da ANS - **A cobertura do hormônio do crescimento indicado pela médica está em consonância com a Resolução Normativa 428, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que dispõe sobre o rol mínimo de procedimento obrigatórios. Afinal, o fornecimento do hormônio do crescimento consta no referido rol da ANS, no anexo I, página 62, conforme se verifica pelo endereço eletrônico da ANS - A seguradora está obrigada ao fornecimento do hormônio do crescimento, vez que o tratamento é de cobertura obrigatória e deve constar no contrato. Embora se trate de medicamento administrado fora do ambiente hospitalar, o fato de constar no rol da ANS é fundamento suficiente para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado** - Havendo cobertura contratual para a patologia que acomete o segurado e constando do rol da ANS, a realização do tratamento em questão nada mais é do que uma consequência da referida cobertura, razão pela qual a negativa em questão é abusiva. Além disso, a necessidade do tratamento não foi questionada, mas sim o direito do segurado ao tratamento ora pretendido - Ante a expressa indicação médica, a negativa de cobertura mostra-se indevida. Afinal, não cabe à operadora de plano de saúde, mas sim ao médico especialista eleger qual o melhor tratamento, que, na hipótese, é o mais indicado para a patologia apresentada pelo paciente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam

os Desembargadores que compõem a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, no sentido determinar a seguradora Unimed Recife a garantir o custeio do Norditropin 15mg (2 unidades/mês) ou Saizen 12 mg (2 unida-des/mês) ou Genotropin 12 mg (2 unidades/mês), ou, ainda, Omnitrop 15mg (2 unidades/mês), de acordo com o laudo médico, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).
(TJ-PE - AI: 00021735120198179000, Relator: ANTONIO FERNANDO ARAUJO MARTINS, Data de Julgamento: 12/10/2020, Gabinete da 1ª Vice Presidência Segundo Grau)

Destarte, considerando que o tratamento se encontra previsto no rol de procedimentos obrigatório da ANS prevista na Resolução nº 465, de 2021, prescrito pelo médico assistente da autora como o mais adequado para a sua recuperação e respaldado no melhor entendimento jurisprudencial, deve a ré arcar com os custos do tratamento hormonal.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, CPC e fundamentos fáticos acima apostos, **julgo procedente** os pedidos elaborados na inicial, confirmando os efeitos da tutela provisória deferida, determinando a condenação do réu no custeio do tratamento médico indicado na inicial com o fornecimento dos medicamentos necessários, conforme prescrição médica.

A ré arcará com o pagamento das custas processuais e verba honorária, está fixada em 10% sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos.

Recife, 13 de março de 2023.

José **Alberto** de Barros **Freitas** Filho

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: **JOSE ALBERTO DE BARROS FREITAS FILHO**
13/03/2023 14:17:08
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **127765431**

23031314170797400000124830433

IMPRIMIR GERAR PDF